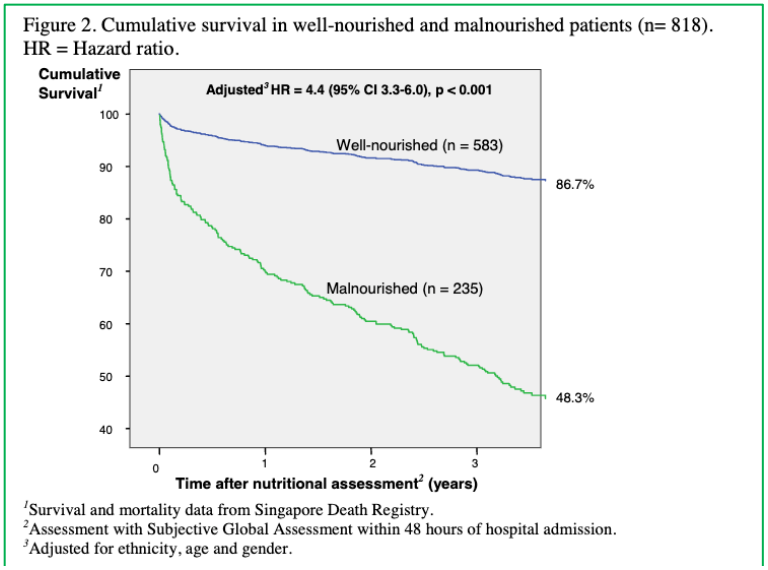
Suivre et dépister les patients dénutris.

Il y a deux bonnes raisons de suivre les patients dénutris ou à risque de dénutrition

La première est médicale et relève du fait que la dénutrition est un facteur d'alourdissement de la pathologie et responsable d'un allongement certain de la durée de séjour.
Cette réalité a poussé au développement de l'alimentation en post-op immédiat des patients (Fast track) afin de permettre une sortie rapide des patients et éviter une dégradation de l'état nutritionnel.

L'état nutritionel des patients a aussi un impact majeur sur le taux de létalité



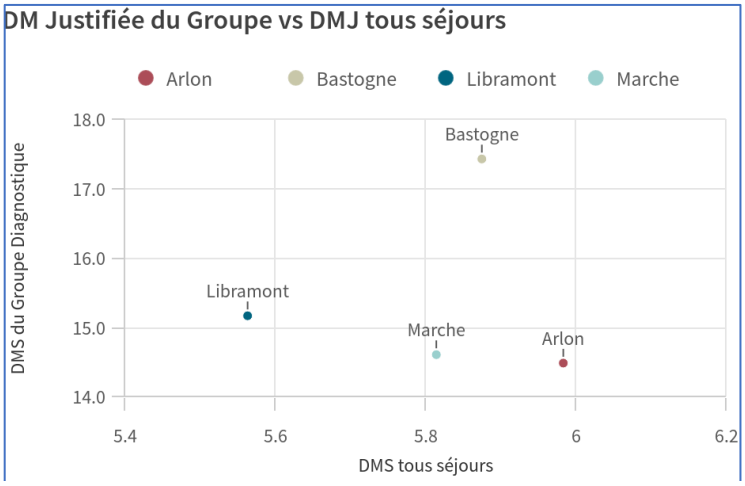
SL Lim, KCB Ong, YH Chan, WC Loke, M Ferguson, L DanielsMalnutrition and its impact on cost of hospitalization, length of stay, readmission and 3-year mortality1Malnutrition and its impact on cost of hospitalization, length of stay, readmission and 3-year mortality

La deuxième découle de la première, à savoir que la dénutrition étant resppnsable d'iun allongement de la durée de séjour, le diagnostic rapide de celle-ci et sa prise en charge nutritionnelle permettent de contrôler la durée de séjour et surtout permettent la codification des codes de dénutrition générant quasi « de Facto » un passage en index de sévérité

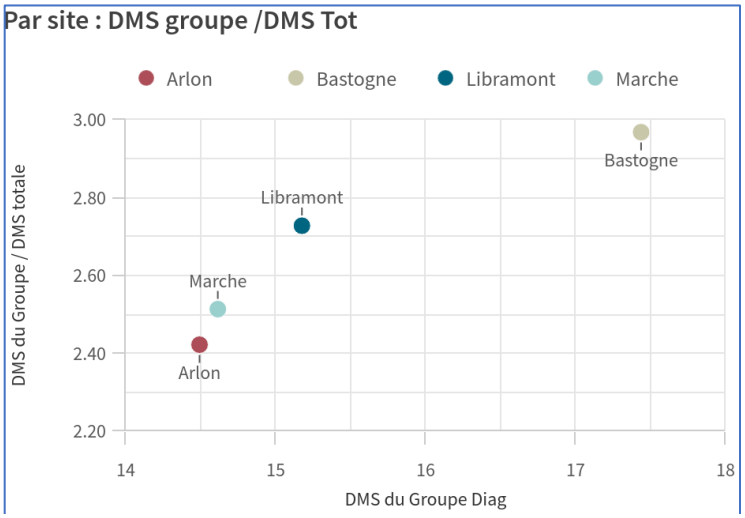
	Index de sévérité			
	Sev 1	Sev 2	Sev 3	Sev 4
E43 - Unspecified severe protein-calorie malnutrition	0,0%	1,7%	58,0%	40,3%
E440 - Moderate protein-calorie malnutrition	0,5%	9,6%	65,8%	24,2%
E441 - Mild protein-calorie malnutrition	2,7%	41,6%	45,7%	9,9%
E46 - Unspecified protein-calorie malnutrition	0,3%	16,6%	55,2%	27,9%
Toute malnutrition confondue	1,6%	25,7%	55,3%	17,4%

Pour la dénutrition sévère, on retrouve 98 % des séjours dans des index de sévérité 3 ou 4
Pour la dénutrition modérée, on en retrouve encore 90 % dans les index 3 et 4

Durée de séjour justifiée des patients pour lesquels une dénutrition a été encodée pour les 4 sites comparée à la durée de séjour justifiée tous patients confondus

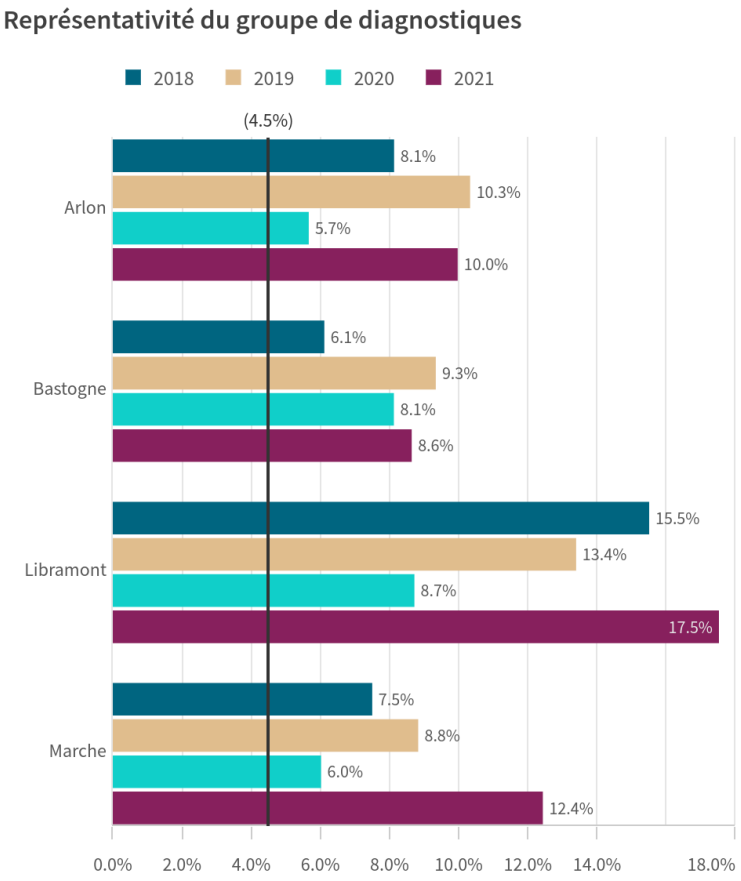


Dans ce schéma, il faut lire par exemple pour Libramont que les patients avec dénutrition justifient 15,2 jours alors que l'ensemble des séjours justifient en moyenne 5,56 jours



Ce schéma montre, quant à lui, que les durées de séjours justifiées pour des patients dénutris sont de 2,42 à 2,97 plus élevées que les patients tout venant selon les sites

Comparaison au Benchmark de 3 M



Dans ce schéma ci, on constate l'effet positif du travail des équipes de diététiciennes en sachant que, pour les hôpitaux repris dans le benchmark, le nombre de patients pour lesquels de la dénutrition a été encodé est de l'ordre de 4,5 % (référence Bench 3M 2021)

On peut tenter une approche de bénéfice retiré au niveau de l'activité justifiée suite à l'action de détection des patients dénutris en se basant sur la référence du Benchmark et de la valeur du point à +/- 27350 € (pour des lits G 37 200 € pour +/- 25% des séjours en dénutrition)

Attention les chiffres sont calculés sur le premier semestre

Arlon										
							A 100%			
Période	n séj	% Nb Tot	n Séj attendu	N sej suppl	DSJ Moy	DSJ M All	Jours suppl	Lits suppl	Impact Suppl	Impact minimal
2018	543	8,13%	300	243	15,1	6,0	2208	7,6	206 810 €	115 813 €
2019	661	10,33%	288	373	15,1	6,0	3383	11,6	316 848 €	177 435 €
2020	301	5,67%	239	62	15,0	6,1	552	1,9	51 722 €	28 965 €
2021	536	9,97%	242	294	12,8	5,8	2070	7,1	193 871 €	108 568 €

Bastogne										
							A 100%			
Période	n séj	% Nb Tot	n Séj attendu	N sej suppl	DSJ Moy	DSJ M All	Jours suppl	Lits suppl	Impact Suppl	Impact minimal
2018	128	6,12%	94	34	16,4	5,7	361	1,2	33 802 €	18 929 €
2019	179	9,34%	86	93	18,6	5,9	1173	4,0	109 863 €	61 523 €
2020	121	8,13%	67	54	18,5	6,1	664	2,3	62 223 €	34 845 €
2021	138	8,64%	72	66	16,1	5,8	680	2,3	63 687 €	35 665 €

Libramont										
							A 100%			
Période	n séj	% Nb Tot	n Séj attendu	N sej suppl	DSJ Moy	DSJ M All	Jours suppl	Lits suppl	Impact Suppl	Impact minimal
2018	831	15,51%	241	590	15,6	5,7	5839	20,0	546 935 €	306 284 €
2019	754	13,39%	253	501	15,9	5,4	5240	17,9	490 773 €	274 833 €
2020	399	8,72%	206	193	16,3	5,8	2035	7,0	190 609 €	106 741 €
2021	822	17,52%	211	611	13,6	5,4	4983	17,1	466 684 €	261 343 €

Marche										
							A 100%			
Période	n séj	% Nb Tot	n Séj attendu	N sej suppl	DSJ Moy	DSJ M All	Jours suppl	Lits suppl	Impact Suppl	Impact minimal
2018	283	7,50%	170	113	15,4	5,8	1084	3,7	101 543 €	56 864 €
2019	328	8,83%	167	161	15,5	6,0	1530	5,2	143 317 €	80 257 €
2020	184	6,02%	138	46	17,9	5,8	561	1,9	52 562 €	29 435 €
2021	415	12,43%	150	265	12,0	5,7	1664	5,7	155 884 €	87 295 €

Ce calcul reprend l'impact à 100%. Il faut néanmoins le pondérer par le fait que certains séjours auraient probablement été en index 3 ou 4 sans la dénutrition

Dans notre étude, la dénutrition représente 56% des codes susceptibles d'amener un index de sévérité 3 ou 4. On peut estimer que maximum 44% des séjours pour lesquels on a codé de la malnutrition auraient probablement été en index de sévérité 3 ou 4 pour d'autres raisons.

Perspectives d'amélioration

Il est à noter que la littérature scientifique détermine que 25% minimum des patients hospitalisés souffre de malnutrition (de 23 à 50 % selon les études)

Le taux de codification en Belgique est nettement en dessous de ces chiffres et même à Vivalia où globalement nous surfons entre 10 et 15 %, on peut évaluer qu'il reste encore une marge de patients non détectés et par là même une source de financement inexploitée.

Conclusions

Le travail de l'équipe nutritionnelle porte ses fruits en permettant la justification de séjours lourds. Le taux de patients avec malnutrition à Vivalia est supérieur au taux que l'on retrouve dans le benchmark de 3M mais il reste en dessous de ce que la littérature internationale réfère.

On peut considérer que les séjours les plus sévères sont bien suivis grâce à l'intervention de l'équipe nutritionnelle mais que l'on pourrait encore améliorer la situation en faisant un screening plus étendu des patients

Le tableau ci-dessous montre l'impact annuel de la codification des séjours avec malnutrition.

Hôpital	n séj	% Nb Tot	n Séj attendu	N sej suppl	DSJ Moy	DSJ M All	Jours suppl	Lits suppl	Impact Suppl	Impact minimal
Arlon	1072	9,97%	484	588	12,8	5,8	4140	14,2	387 742 €	217 136 €
Bastogne	276	8,64%	144	132	16,1	5,8	1360	4,6	127 374 €	71 330 €
Libramont	1644	17,52%	422	1222	13,6	5,4	9966	34,2	933 368 €	522 686 €
Marche	830	12,43%	300	530	12	5,7	3328	11,4	311 768 €	174 590 €
Vivalia	3822		1350	2472			18794	64,4	1 760 252 €	985 742 €

Dans ce tableau, pour l'année 2021 (2X le premier semestre), on regarde l'effet du codage au-delà de la norme de 3M en nombre de séjour ainsi qu'en impact sur le BMF

L'impact minimal est calculé en considérant que 44% des séjours auraient de toute manière été justifiés en index de sévérité 3 ou 4 par d'autres complications que la malnutrition.

Hypothèse de travail et d'amélioration

En considérant la littérature internationale qui parle de 23 à 50 % de dénutrition chez les patients hospitalisés selon les régions , on prend comme valeur cible le taux de 20% de dénutrition. La durée de séjour , tous patients confondus au niveau international est allongée de 4 jours en moyenne . Nous prendrons comme hypothèse que l'encodage de dénutrition chez les patients apporte une justification identique à l'allongement de durée de séjour même si l'impaact est probablement plus important en terme de justification.

Le réservoir financier que la réalisation d'un tel objectif pourrait amener est repris dans le tableau ci-dessous

	n séj	% Nb Tot	Impact Suppl	Impact minimal	% suppl	Nb Suppl	Impact	Impact Total possible	Impact minimal possible
Arlon	1072	10,0%	387 742 €	217 136 €	10,03%	1078	404 050 €	791 792 €	621 186 €
Bastogne	276	8,6%	127 374 €	71 330 €	11,36%	363	135 959 €	263 333 €	207 289 €
Libramont	1644	17,5%	933 368 €	522 686 €	2,48%	233	87 187 €	1 020 555 €	609 873 €
Marche	830	12,4%	311 768 €	174 590 €	7,57%	505	189 381 €	501 149 €	363 971 €
Vivalia	3822		1 760 252 €	985 742 €		2180	816 578 €	2 576 830 €	1 802 320 €

On voit que le travail actuel de l'équipe nutritionnelle et le codage des malnutritions apporterait aujourd'hui près d'un million d'euros et qu'en augmentant le screening à plus de patients on. Pourrait améliorer le B2 de près de 800.000 euros supplémentaires